

Ugonjwa wa Ebola

[Original English version published online:] 11 Décembre 2025

This Congolese Kiswahili version published online September 25, 2026

11 Desemba 2025 | Maswali na Majibu

Ebola ni ugonjwa gani?

Ebola ni ugonjwa usiyo wa kawaida lakini wa hatari sana, unaosababishwa na virusi vinavyotoka katika kundi la *Orthoebolavirus* la familia ya *Filoviridae*. Katika milipuko iliyopita, kiwango cha vifo kilikuwa kati ya 25% hadi 90%.

Hadi sasa, aina sita za virusi vya *Orthoebolavirus* zimetambuliwa, na aina tatu zinajulikana kusababisha milipuko mikubwa :

- Virusi vya Ebola (EBOV) vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola
- Virusi vya Sudani (SUDV) vinavyosababisha ugonjwa wa Sudani
- Virusi vya Bundibugyo (BDBV) vinavyosababisha ugonjwa wa Bundibugyo

Mnyama anayebeba virusi hivi kwa kawaida bado hajajulikana kikweli, lakini ushahidi wa sasa unaonyesha kwamba popo wanaokula matunda (*Pteropodidae*) wanaweza kuwa ndiyo waliyoleta virusi hivyo.

Alama za kawaida za ugonjwa wa Ebola ni gani?

Alama za ugonjwa wa Ebola zinaweza kuanza kwa rafla, nazo ni hizi:

- homa
- muchoko mwingi
- maumivu ya mishipa
- maumivu ya kichwa na maumivu ya koo

Alama hizi zinaweza sindikizwa na :

- kutapika
- kuhara
- upele kwenye ngozi

- kutokwa damu ndani ya mwili au nje ya mwili.

Inachukua muda gani mtu kuonyesha alama hizo baada ya kuambukizwa?

Muda kati ya kuambukizwa na kuanza kuonyesha alama ni kati ya siku 2 hadi 21. Mtu anaweza kuambukiza wengine tu baada ya kuanza kuonyesha alama za ugonjwa.

Hata kama mtu ana alama zinazofanana Ebola, ni uchunguzi wa waganga pekee unaweza hakikisha kama kweli ni ugonjwa wa Ebola.

Kuna tofauti gani kati ya ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengine yenye alama zinazofanana?

Alama za ugonjwa wa Ebola mara nyingi huanza kwa rafla na zinahitaji huduma ya haraka kutoka kwa wahudumu wa afya waliofunzwa.

Kwa sababu alama zake zinafanana, inaweza kuwa vigumu kutofautisha Ebola na magonjwa mengine ya kuambukiza kama malaria, tifoide, dengue na ugonjwa wa virusi vya Marburg.

Kwa hiyo, ni muhimu sana kwamba watu wenye alama zinazofanana na hizo za Ebola watafute ushauri mara moja kwa mtoa mashauri ya afya. Kupimwa ndiyo hatua ya kwanza ya kujua kwa ukweli kinachosababisha ugonjwa na ni muhimu ili kutoa matibabu sahihi. Kupima na kutunza mapema inaokoa maisha na inalinda jamii pamoja na wanafamilia, wakiwemo wahudumu wa afya na walezi wa wagonjwa.

Ugonjwa wa Ebola unaambukia namna gani?

Ugonjwa wa Ebola mara nyingi unaambukia kutoka kwa mtu kwenda kwa mwingine kupitia kugusa damu au majimaji mengine ya mwili (mara nyingi kupitia kubusana, vitapikio, jasho na mate) ya mtu aliyeambukizwa, akiwa hai au amekufa.

Majimaji hayo ni pamoja na:

- mavi
- vitapikio
- jasho
- mate

Maambukizi yanatokea wakati virusi vinaingia ndani yamwili kupitia ngozi yenye kuumiya (kidonda) ao kupitia sehemu laini za mwili kama:

- Macho
- pua
- mdomo.

Hali hii yatokea mara nyingi wakati mtu anamuhudumia mgonjwa ao anagusa mwili wa mtu aliyekufa kutokana na Ebola.

Ebola inaweza pia kusambazwa kwa kugusa ao kutumia vitu vilivyochafuliwa na majimaji ya mwili ya mgonjwa ao mtu aliyekufa kwa Ebola.

Katika matokeo machache, mwanaume aliyepona Ebola anaweza kumuambukiza mwenzi wake wa ngono, kwa sababu virusi vinaweza kubaki kwa muda katika mbegu za kiume hata baada ya kupona.

[Watu wanapashwa kufanya nini kwa kujilinda wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola?](#)

Wakati wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, watu wanaweza kujilinda kwa kuchukua hatua zinazopunguza hatari ya maambukizi. Hatua hizo ni pamoja na:

- kuepuka kugusana kimwili na watu wanaosemewa ao waliohakikishwa kuwa na Ebola;
- kuepuka kugusa miili ya watu waliokufa wakiwa na alama za Ebola bila kutumia vifaa vya kujikinga;
- kunawa mikono mara kwa mara kwa kufuata maelekezo ya viongozi na wahudumu wa afya kuhusu namna ya kunawa mikono.

[Watu wanaweza kufanya nini ili kujikinga na maambukizi kutoka kwa wanyama?](#)

Watu wanaweza kujilinda na maambukizi kutoka kwa wanyama kwa:

- kuepuka kula au kugusa wanyama waliokufa bila kinga, hasa wakati wa mlipuko wa Ebola;
- kunawa mikono vizuri kabla na baada ya kugusa wanyama ao vitu vinavyotokana na wanyama;
- kupika vizuri chakula kutoka wanyama, kama damu na nyama, kabla ya kula.

Ni watu gani wanaokuwa katika hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa?

Wakati wa mlipuko wa Ebola, watu walio katika hatari kubwa zaidi ya maambukizi ni:

- wahudumu wa afya na walezi wanaokuwa karibu sana na wagonjwa;
- walezi, wanafamilia au watu wengine wanaogusana moja kwa moja na watu walioambukizwa;
- waombolezaji wanaogusa miili wakati wa mazishi au desturi za maziko.

Kwa nini wahudumu wa afya wapo katika hatari kubwa zaidi ya kupata Ebola?

Mara nyingi, wahudumu wa afya na walezi ni wa kwanza kugundua magonjwa mapya katika jamii, kutoa habari na kuwaelekeza wagonjwa kwenye vituo vya afya.

Wahudumu wa afya wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa wakati:

- hawatumii vifaa kamili vya kujikinga (PPE);
- hawafuati hatua za kuzuia na kumaliza maambukizi (IPC) wanapowahudumia wagonjwa au kushurulikia miili ya waliokufa.

Kwa sababu alama za Ebola zinafanana na magonjwa mengine ya kawaida, wahudumu wa afya wanaweza kutotumia mara moja hatua sahihi za kujikinga na maambukizi.

Watu wanaweza kufanya nini kiisha kugusana na mtu mwenye Ebola?

Ikiwa umemgusa mtu aliyeambukizwa au anayesemewa kuwa na Ebola, unaweza kuwa katika hatari ya kupata ugonjwa huo. Ni heri kujielekeza kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili wakupangie hatua zinazofuata.

Baada ya kutambuliwa kuwa “uligusana na mgonjwa”, afya yako itafuatiliwa kwa siku 21 nyuma ya mgusano huo. Waongozi ama wahudumu wa afya watacupatiya maelekezo:

- kukubali kutembelewa kila siku na kundi la ufuatiliaji wa watu waliogusana na mgonjwa;
- kuruhusu kupimwa joto la mwili;
- kujibu maulizo yote kwa utaratibu na kuuliza maswali yoyote uliyo nayo;
- kutoa habari mara moja ukianza kuwa na alama;

- kuepuka safari bila kujadiliana mamlaka za afya;
- kupata chanjo ya ndui ikiwa inapatikana. Pia, inaomba uwataje watu uliogusana nao ili nao wapewe chanjo.

Alama za ugonjwa zikionekana ndani ya kipindi cha siku 21 za ufuatiliaji, utaelekezwa kwenda kwenye kituo maalumu cha matunzo. Wakikuomba kufanya vipimo, matokeo yatawaongoza wahudumu wa afya kuamua kama unahitajika kwenda katika kituo cha matunzo au hapana.

Je, kuna matunzo ya Ebola?

Kuna majaribio mawili ya matibabu ya majaribio kwa Ugonjwa wa Virusi vya Bundibugyo (BVD). Jaribio la kwanza linaitwa PARTNERS. Katika jaribio hili, wagonjwa wa umri wote, pamoja na wanawake wajawazito, watapewa matibabu ya kingamwili maalumu zinazoitwa MBP134 pamoja na dawa ya kuzuia virusi iitwayo remdesivir.

Kwa watu waliokutana kwa karibu na wagonjwa na wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa, kutakuwa na jaribio la kinga baada ya kuambukizwa (post-exposure prophylaxis). Watu wenye umri wa miaka 12 na zaidi watapewa dawa ya obeldesivir au placebo (dawa isiyo na kiungo cha matibabu), kwa njia ya kuchaguliwa kwa nasibu (randomized), baada ya kutoa ridhaa yao.

Kwa watoto walio chini ya miaka 12 na wanawake wajawazito, katika mpango huu wa kinga baada ya kuambukizwa, dawa ya remdesivir itatolewa kwa utaratibu wa matumizi ya huruma (compassionate use). Majaribio haya yanalenga kubaini kama matibabu haya yanafaa na yana uwezo wa kutibu au kuzuia Ugonjwa wa Virusi vya Bundibugyo (BVD).

Matunzo mengine mapya yanaendelea kuchunguzwa kwa aina nyingine za virusi vya *orthoebolavirus*, lakini bado hayajakamilika kupimwa.

Ikiwa wewe au mtu wa familia yako amepatikana na Ebola, ni muhimu kupata matunzo mapema katika kituo maalumu cha matibabu kwani inaweza kuponyesha. Huduma hutolewa bila malipo, pakiwemo kupewa maji ya kutosha mwilini, malisho bora, matunzo.

Kutunzwa mapema huongeza uwezekano wa kupona na kuzuia maambukizi ndani ya jamii na familia.

Majoribio ya uwezo wa ndui ya ChAdOx1 BDBV, yenyi imetengenezwa kama kinga ya kuzuia virusi vya Bundibugyo (BDBV), pamoja na ndui ya Ervebo, ambayo ilitengenezwa kwa ajili ya aina nyingine za virusi vya Ebola lakini inaweza kutoa tena kinga kwa virus ya BDBV, yanaanza ili kuchunguza uwezo wa ndui hizi katika kuzuia maambukizi ya BDBV. Siku hizi, hakuna hata moja kati ya chanjo hizi mbili ambayo imepata ruhusa kamili ya kisheria kwa ajili ya kinga kuhusu virusi ya BDBV. Kwa hiyo, majoribio haya yatasaidia kuhakikisha ikiwa chanjo hizo zinaweza kuruhusiwa kabisa kwa matumizi hayo.

Jaribio la ndui ya Misiri itaanzishwa hivi karibuni na Minapharm.

[Je, watu wenye Ebola wanaweza kutunzwa nyumbani?](#)

Kituo cha Afia Ulimwenguni (WHO) haishauri familia au jamii kushurulikwa watu wenye ugonjwa wa Ebola nyumbani. Watu wenye alama wanapashwa kutafuta usaidizi katika kituo cha afya.

Usaidizi wa mapema katika kituo maalumu cha afya ni vizuri sana na inaweza kuongeza nafasi ya kupona.

Ikiwa mtu atafariki nyumbani akiwa anashutumiwa kuwa na Ebola, wanafamilia au wanajamii hawapashwi kugusa au kuandaa mwili kwa ajili ya mazishi.

Jamii au wanafamilia wanapashwa kuwasiliana mara moja na mamlaka za afya za eneo lao ili kufanya mazishi salama na yenye heshima kulingana na matakwa ya familia.

[Watu wanapashwa kufanya nini ikiwa wanataka kusafiri wakati wa mlipuko wa Ebola?](#)

Kituo cha Afia Ulimwenguni (WHO) haipendekezi vizuizi vya biashara au usafiri kama kufungwa kwa maeneo (lockdown) au karantini katika maeneo yaliyoitikiwa na Ebola.

Hata hivyo, safari za watu waliogusana karibu na wagonjwa wa Ebola zinapashwa kupunguzwa au kuongezewa siku mpaka wakati inapowezekana.

Hii ni kwa ajili ya kulinda watu wanaoweza kuambukizwa wakati wa safari na kuzuia kuenea kwa virusi.

Ikiwa safari ya mtu aliyegusana na mgonjwa ni lazima, safari hiyo inapashwa kuruhusiwa na kusimamiwa na mamlaka za afya ya umma ili kuhakikisha ufuatiliaji unaofaa katika eneo analokwenda.

.....

Translated and adapted into Congolese Kiswahili by Jacques Muisha under the supervision of Ombeni Mtanga for Athinkra, LLC based on “Ebola disease: Questions and answers”, WHO, December 11, 2025. WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency between the English and the Congolese Kiswahili translation, the original English version (<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ebola-disease>) shall be the binding and authentic version.